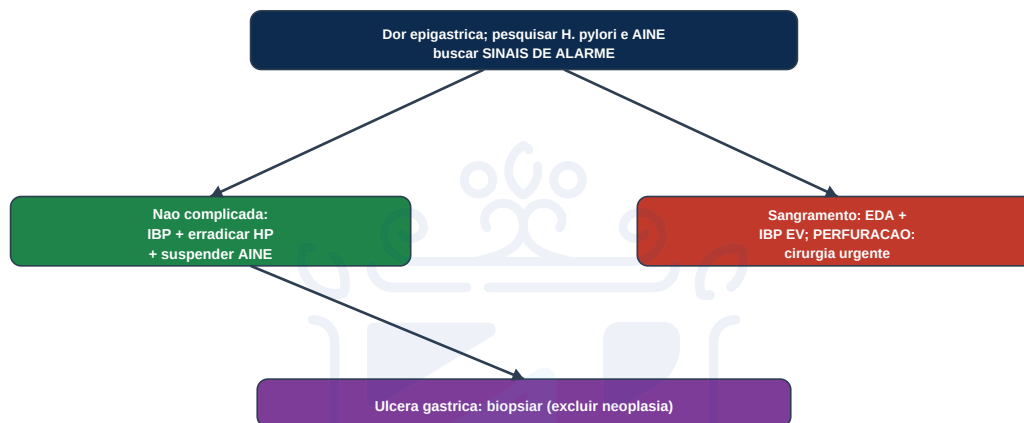


ÚLCERA PÉPTICA — H. PYLORI + IBP

FLUXOGRAMA — NÃO COMPLICADA x COMPLICAÇÃO

ÚLCERA PÉPTICA — DOR EPIGÁSTRICA -> ALARME?



DEFINIÇÃO E RISCO

O QUE É

- Perda focal da mucosa gástrica/duodenal que ultrapassa a muscular da mucosa
- Causas principais: H. PYLORI, AINEs/AAS, estresse (criticamente enfermos)
- Risco: AINE/AAS/corticoide, tabagismo, álcool, idade avançada, úlcera prévia, comorbidades
- Dor: duodenal MELHORA com alimento; gástrica pode PIORAR; pirose, plenitude pós-prandial
- Complicações: sangramento, perfuração, obstrução

SINAIS DE ALARME

INDICAM EDA / INVESTIGAÇÃO

- Hemorragia digestiva alta: hematêmese, melena, queda de Hb
- Vômitos persistentes / sinais de obstrução
- Perda ponderal, disfagia, anemia
- Idade > 60 anos com sintomas dispépticos NOVOS
- Dor súbita intensa + abdome rígido = PERFURAÇÃO até prova em contrário

Suporte ao Plantão Médico

TRATAMENTO — NÃO COMPLICADA

Rx IBP + ERRADICAÇÃO + MEDIDAS

Suspender AINE/AAS quando possível; cessar tabagismo, reduzir álcool

IBP: Omeprazol 20-40 mg/dia (ou 20 mg 12/12h se sintomas intensos); duodenal 4-6 semanas, gástrica 8 semanas (reavaliar com EDA)

Pesquisar H. pylori (antígeno fecal/teste respiratório; suspender IBP 2 semanas antes quando viável)

Erradicação de HP (quádruplo com bismuto, 10-14d): IBP 12/12h + bismuto + tetraciclina 500 mg 6/6h + metronidazol 500 mg 8/8h

Alternativa (baixa resistência): IBP 12/12h + amoxicilina 1 g 12/12h + claritromicina 500 mg 12/12h por 14d

Confirmar erradicação 4-8 semanas após o término; EDA na úlcera gástrica para confirmar cicatrização (e biopsiar)

COMPLICAÇÕES — SANGRAMENTO E PERFURAÇÃO

Rx EMERGÊNCIAS

SANGRAMENTO: ABCDE, reposição volêmica, cruzar hemocomponentes; EDA urgente para hemostasia (Forrest); IBP EV alta dose (pantoprazol 80 mg bolus + 8 mg/h por 72h)

Falha endoscópica -> embolização ou cirurgia; investigar/tratar HP antes da alta

PERFURAÇÃO: dor súbita + abdome em tábua; RX ortostático mostra pneumoperitônio (ar subdiafragmático); TC mais sensível

Conduta: ABCDE, jejum, SNG, cristalóide; ATB EV imediato (Pipe-tazo 4,5 g 6-8/8h, ou Ceftriaxona 2 g + Metronidazol);

Pantoprazol 40 mg EV 12/12h

CIRURGIA de urgência: sutura primária + patch de omento (GRAHAM) ± drenagem

Instável: otimizar volemia/noradrenalina; não atrasar a cirurgia por exames irrelevantes

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR/UTI: sangramento ativo/instabilidade, perfuração, vômitos persistentes, complicação (obstrução), necessidade de EDA/embolização, comorbidades
- ☐ ALTA (não complicada): dor controlada VO, sem sangramento, Hb estável, tratamento de HP iniciado se indicado, plano de seguimento/EDA
- ☐ Orientações de alarme: hematêmese, melena, dor súbita intensa, síncope, febre, vômitos persistentes
- ☐ Evitar AINE; se imprescindível, proteção com IBP
- ☐ Em dúvida com dispepsia funcional, valorizar os sinais de alarme

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com dor epigástrica; uso de AINE ____; H. pylori ____; sinais de alarme ____.
- Complicação: sangramento (Hb ____) / perfuração (pneumoperitônio ____); sinais vitais ____.
- Condutas: jejum, SNG, fluidos, ATB ____ (se perfuração), IBP EV ____, analgesia; hemocomponentes ____.
- Solicito EDA urgente (sangramento) ou cirurgia de urgência (perfuração) ± UTI.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com dor epigástrica súbita e intensa, abdome em tábua e RX com ar subdiafragmático. Qual o diagnóstico e a conduta?

- A) Gastrite; alta com IBP oral
- B) Úlcera péptica PERFURADA; jejum, ATB EV, IBP EV e cirurgia de urgência (Graham)
- C) Pancreatite; apenas hidratação
- D) Dispepsia funcional; ansiolítico
- E) Cólica biliar; analgesia e alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a duração recomendada de IBP para a úlcera GÁSTRICA não complicada?

- A) 1 semana
- B) 8 semanas, com EDA de controle para confirmar cicatrização (e biópsia)
- C) 24 horas
- D) 6 meses sempre
- E) Não usar IBP

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

No sangramento por úlcera péptica, qual a conduta-chave após a estabilização?

- A) Cirurgia imediata em todos
- B) Endoscopia digestiva alta urgente para hemostasia + IBP EV em dose alta
- C) Apenas observação
- D) Antibiótico oral
- E) Alta precoce

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Por que toda úlcera GÁSTRICA deve ser biopsiada?

- A) Para pesquisar varizes
- B) Para excluir neoplasia (câncer gástrico)
- C) Para medir o pH
- D) Para avaliar motilidade
- E) Não há necessidade de biópsia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual o esquema de erradicação de *H. pylori* preferível em áreas de alta resistência?

- A) IBP isolado
- B) Terapia quádrupla com bismuto (IBP + bismuto + tetraciclina + metronidazol) por 10-14 dias
- C) Amoxicilina isolada
- D) Apenas claritromicina
- E) Metronidazol isolado por 3 dias

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor súbita + abdome em tábua + pneumoperitônio (ar subdiafragmático) é úlcera perfurada: jejum, SNG, ATB EV, IBP EV e cirurgia de urgência (sutura primária + patch de omento de Graham).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A úlcera gástrica não complicada usa IBP por 8 semanas, com EDA de controle para confirmar a cicatrização e biopsiar (excluir neoplasia); a duodenal, 4-6 semanas.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Após estabilizar o sangramento, a EDA urgente permite a hemostasia endoscópica (classificação de Forrest), associada a IBP EV em dose alta; falha endoscópica indica embolização/cirurgia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A úlcera gástrica deve ser biopsiada para excluir câncer gástrico, e a EDA de controle confirma a cicatrização. A úlcera duodenal benigna não exige biópsia rotineira.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Em áreas de alta resistência prefere-se a terapia quádrupla com bismuto (IBP + bismuto + tetraciclina + metronidazol) por 10-14 dias; a tríple com claritromicina depende da resistência local.

SM24
Suporte ao Plantão Médico